Feedback del sitio «Más que Urticaria»

Comentarios de la PPT y respuesta a cada uno · Octubre 2026

SÍ: 21 | REQUIERE DECISIÓN: 9 | NO APLICA: 4

Slide	Comentario	Veredicto	Respuesta
Síntomas			
16	¿Pondrán hasta abajo qué es UCE?	SÍ	Sí. Bajar la tabla comparativa al final; arriba solo una definición corta.
17	Imágenes en lugar de la descripción con letra mini.	SÍ	Sí. Foto por tarjeta con nombre debajo. Requiere banco de imágenes con revisión médica.
19	Imágenes en vez de texto. Perfiles: ¿para qué son? Referencias y objetivo.	DECISIÓN	Imágenes: sí. Perfiles (Mujeres/Niños/Hombres): hoy no tienen objetivo ni fuente. Recomendación: quitar.
20	¿Tenemos evidencia de que empeore por la noche? ¿Fuentes confiables?	SÍ	Pregunta correcta: la FAQ no cita fuente. Conseguir fuente o quitar/reformular (también afecta Q13).
21	Letras chiquitas: wording amigable para llegar a la cita con datos completos.	SÍ	Sí. Propuesta: «Llega a tu cita con tus síntomas anotados: tu médico podrá valorarlos mejor.»
Tratamientos			
23	Comezón y misma pregunta de «la tarde».	DECISIÓN	Comentario ambiguo. Lectura: título y párrafo repiten la idea de «la tarde». Dejar una sola formulación; confirmar.
24	Quitar «necesariamente». Demasiado texto, misma info.	SÍ	Sí a ambos. Fusionar o eliminar la sección que repite el intro.
25	Corticoides: NO. Sección causa ruido, no alineada a guías. Yo la quitaría.	DECISIÓN	De acuerdo en quitarla (también su FAQ). Falta confirmación de Novartis/Médico. Regla: «Habones (ronchas), hinchazón (angioedema)».
26	Quitar cuadro de sin receta/cremas y remedios caseros; «visita a tu médico» + link al directorio. ¿La sección suma?	SÍ	Sí a los tres cambios. Sección: dejar mínima (compresas, ropa holgada) o eliminarla y usar CTA al directorio.
27	Agregar link «Encuentra a un especialista»; quitar detalle de especialidad; letras chiquitas no se ven.	DECISIÓN	Link y quitar detalle: sí. Letras chiquitas: validar con Legal antes de quitar.
28	¿Qué sale en el +? Esta sección no me hace sentido.	SÍ	Sale la respuesta de la FAQ (acordeón). Sin corticoides queda vacía: eliminar o reescribir.
29	Quitar las mini letras.	DECISIÓN	Depende de Legal: si son aviso obligatorio, no se quitan.
Sobre nosotros			
30	Leyenda «Recuerda: únicamente un profesional de la salud…» en recomendaciones farmacológicas.	NO APLICA	No aplica a esta pantalla (es el encabezado de Sobre nosotros). Sí como regla en Tratamientos.
31	Quitar «sitio desarrollado con patrocinio de Novartis» (irá en el pie). Más creativo, menos texto.	SÍ	Sí, si el pie ya lleva la leyenda aprobada por Legal. Condensar con tarjetas.

32	Misma leyenda; mostrar síntomas con imágenes e IEEE; link directo a «Encuentra a tu especialista».	NO APLICA	Leyenda e imágenes: no aplican (parecen pegados de otra página). Link directo: sí.
33	¿Recomendamos opciones? Mejor «Visite a un médico». ¿Pregunta o claim genérico?	SÍ	Sí. Claim breve + botón al directorio en lugar de más texto.
Recursos			
35	Wording de apoyo: «Vivir con Urticaria es escucharte y anotar tus síntomas». Promover UAS7/UCT.	SÍ	Sí. Reescribir encabezado y conectar con el quiz (UAS7 sujeto a validación médica).
36	Promover UAS7 y UCT conectadas al test. Creativo, fácil, rápido.	SÍ	Sí, igual que slide 35.
37	La UCE no son solo ronchas. Marcar síntomas y las 6 semanas o más.	SÍ	Sí. Definición destacada con ronchas, comezón, hinchazón/angioedema y ardor (hoy falta «ardor»).
38	Agregar todos los síntomas de la UCE.	SÍ	Sí. Faltan angioedema y ardor en la biblioteca.
Diario			
39, 41, 44, 45	Enseñar a registrar ronchas e hinchazón con UAS7/UCT.	SÍ	Sí. Incorporar el conteo UAS7 al diario.
39, 41, 44, 45	El diario está bien, pero facilitar el acceso 24/7, no solo con wifi.	NO APLICA	No tiene sentido para un sitio web: necesita conexión para abrirse. Ya está disponible 24/7. Solo aplicaría con app/PWA, que no es el alcance.
42	Imágenes de ejemplo de habones y angioedema. El texto pierde al paciente.	SÍ	Sí. Mismo banco de imágenes que slide 17.
Testimonios			
46	«Historias reales» → «No eres el único que confundieron una alergia con UCE».	SÍ	Sí. Conecta emocionalmente y desmiente el mito.
48	Agregar prevalencia e incidencia con burbujas, si se encuentra.	DECISIÓN	Buena idea solo si hay dato citable (Medical Affairs).
50	Redirigir directo a búsqueda de médico. Todos los testimonios son anónimos.	SÍ	Sí. Aviso de anonimato visible.
Quiz			
57, 58	Agregar imágenes (Q1, Q1b).	SÍ	Sí, con revisión médica (Q1b es descarte de urgencia).
60	Cuadro por semanas: UCE con 6 semanas o más (Q2).	SÍ	Sí. Es el criterio clave.
61–63	Q3–Q5 con escala tipo UAS7 (flecha y color). Adjunto ejemplo.	DECISIÓN	Sí, pero es rediseño y hay que revalidar el score. El ejemplo adjunto no venía en el archivo.
64–70	Q6–Q11 en escala tipo UAS7; entrenar al paciente.	DECISIÓN	Sí, con un solo componente reutilizable y rápido. Cuidar la longitud.
71	Q12: no hay desencadenantes; preguntar por mitos que escuchan.	DECISIÓN	Sí; cambia el texto del resultado («tus brotes se ven influenciados por…»). Validar con Médico.
72	Usar «ronchas» en vez de «brotes» (Q13).	SÍ	Sí. Aplicar también a los resultados.

76	Q17: si contesta sí, preguntar qué tratamiento usó.	NO APLICA	Ya existe: Q18 lo pregunta cuando Q17 = Sí (slide 77).
General			
104	Apartado de referencias por cada ventana del sitio.	SÍ	Sí. Estilo IEEE; pendiente de contenido médico.